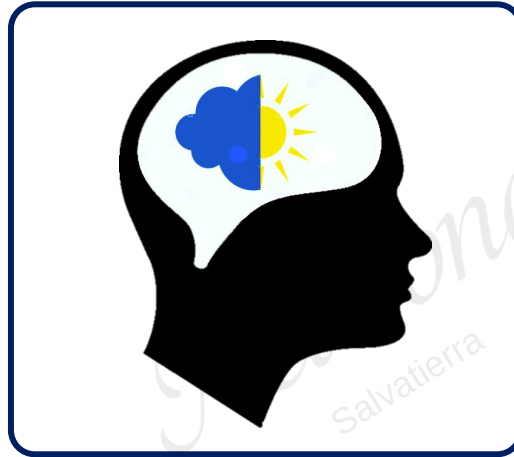


Estabilizadores del humor

Dr. Andréé Salvatierra

Trastorno bipolar



En el trastorno bipolar, básicamente se puede encontrar:

Aumento de la excitabilidad (anormalidad en la bomba Na^+/K^+) → Manía

Disminución de la liberación de los neurotransmisores → Depresión

Eutimizantes

Los estabilizadores del ánimo son agentes dirigidos al control y prevención de episodios de manía y depresión en el trastorno bipolar.

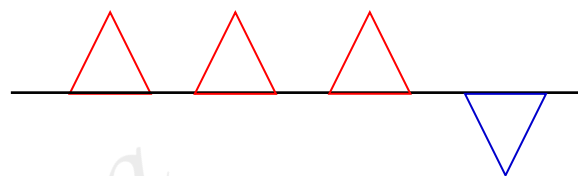
Su mecanismo de acción consiste en:

- ☐ Estimulación colinérgica (incremento de ACh)
- ☐ Inhibición catecolaminérgica (Disminuye DA y NA → acción antimaníaca)
- ☐ Estimulación serotoninérgica (incrementa 5-HT → efecto antidepresivo)

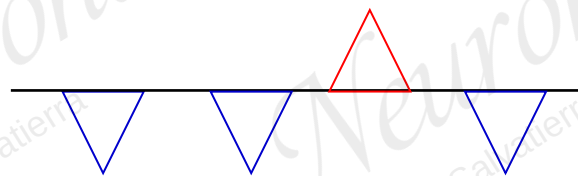
Polaridades

Antes iniciar el tratamiento, es necesario identificar la polaridad predominante en el paciente.

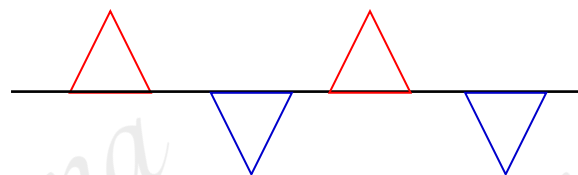
polaridad predominante - **MANÍACA**



polaridad predominante - **INDETERMINADA**



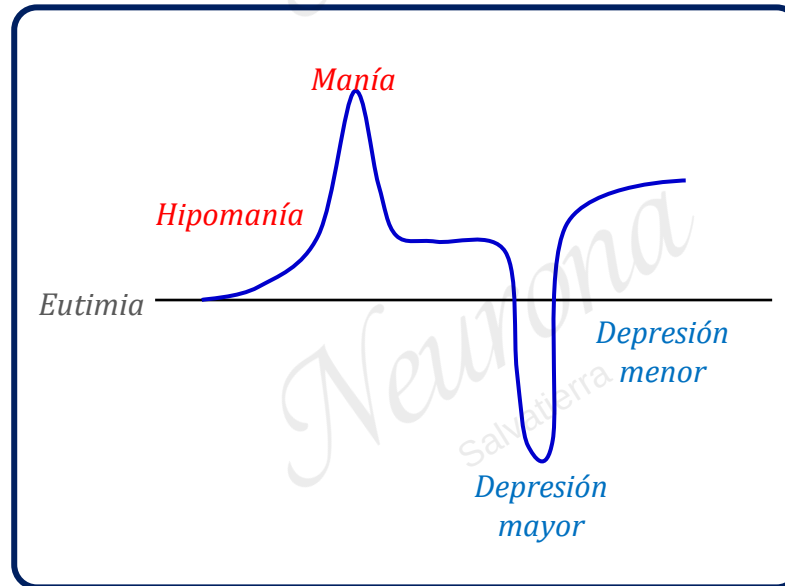
polaridad predominante - **DEPRESIVA**



Clasificación de estabilizadores

Tipo A

Agentes que estabilizan desde arriba (antimaníacos)
T. Bipolar I



Agentes que estabilizan desde abajo (antidepresivos)
T. Bipolar II



Tipo B

Ciclotímico

Períodos hipomaníacos con periodos depresivos alternos de intensidad leve

Cicladores rápidos

Manía + Depresión, 4 veces al año

Agentes terapéuticos

- ☐ **Anticonvulsivantes** (*Valproato, Carbamazepina*)
- ☐ **Antipsicóticos convencionales** (*Haloperidol, Clorpromazina*)
- ☐ **Antipsicóticos Atípicos** (*Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, Ziprasidona, Aripiprazol, Clozapina*)
- ☐ **Benzodiazepinas** (*Lorazepam, Clonazepam*)



Si no se encuentra respuesta hasta la 2ª semana, ha de considerarse:

- ✓ Añadir un AA
- ✓ Añadir un 2do eutimizante (preferentemente litio o valproato)

Si existe depresión estacional, puede considerarse la terapia lumínica

Litio

Ion cuyo mecanismo de acción es incierto, se cree que estabiliza los receptores de catecolaminas y aumenta la actividad GABA ($\downarrow$), siendo un agente comúnmente utilizado para el tratamiento de fases maníacas.

Sus efectos pueden tardar en aparecer 7 - 15 días, es factible combinarse con neurolépticos en episodios agudos de manía.

Es necesaria una función renal satisfactoria para eliminarla, Por otro lado, es necesaria la monitorización terapéutica del fármaco para evitar litemias (concentración que ha alcanzado en la sangre 12h después)

Los efectos secundarios(sobre todo al inicio): Sedación, temblor, fatiga, debilidad muscular, poliuria/polidipsia, diarrea, vómitos, dolor de estómago, incremento de peso, alteración de la función tiroidea y reacciones cutáneas; por lo cual muchos pacientes no pueden tolerarlo.

- ❑ **Episodios maníacos agudos:** 300 a 600mg tres veces al día, dosis habitual 300mg tres veces al día,

Anticonvulsivos

(estabilizadores del estado de ánimo)

Combinar
 $Val + \frac{Lamotrigina}{2}$

- **Carbamacepina** (400-1600 mg/día) monoterapia
- **Valproato** (1000-3000 mg/día)
- **Lamotrigina** (50-300 mg/día)
- **Gabapentina** (900-3200 mg/día)
- **Topiramato** (100 -500 mg/día)

Los anticonvulsivos potencian la neurotransmisión GABA (↓) y reducen la neurotransmisión excitatoria debida al Glutamato (↑)

Eficacia anticonvulsivos

(estabilizadores del humor)

	Manía	Depresión	Prevención recaída
Carbamazepina	+	+	+
Valproico	++	+	++
Lamotrigina	-	+	++ (principalmente depresivos)
Gabapentina	-	+/-	?
Topiramato	-	+/-	+

Eficacia antipsicóticos atípicos

(estabilizadores del humor)

- ☐ **Risperidona** (2-6 mg/día)
- ☐ **Ziprasidona** (80-160 mg/día)
- ☐ **Aripiprazol** (10-30mg/día)
- ☐ **Olanzapina** (10-20 mg/día)
- ☐ **Quetiapina** (50 -600 mg/día)

Efectos secundarios antipsicóticos atípicos

(estabilizadores del humor)

AA	Risperidona	Ziprasidona	Olanzapina	Quetiapina
Efectos extrapiramidales	++	+	+	+/-
Elevación de prolactina	++	+	+	0
Hipotensión	+	+	+	+
Efectos Anticolinérgicos	0	0	++	0
Sedación	+	++	++	++

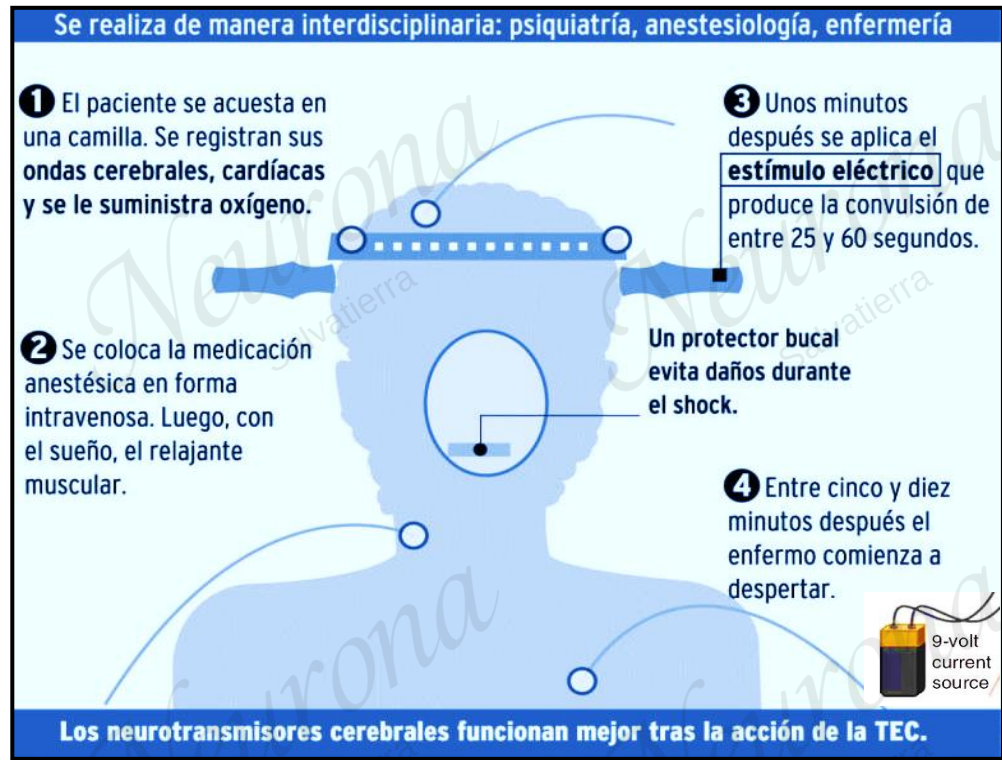
*Terapia electroconvulsiva

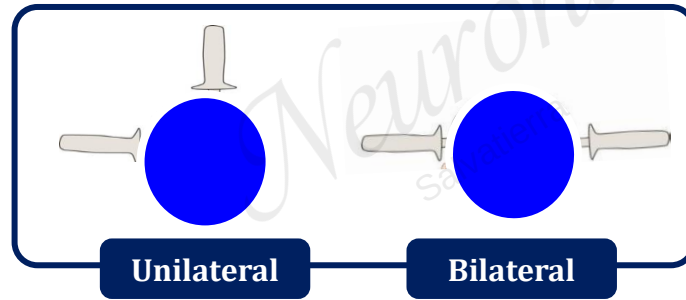
Su descubrimiento, anterior al de la revolución psicofarmacológica, hizo que se utilizara de forma abusiva, se administraba sin anestesia como una forma de castigo para mantener tranquilos a los pacientes.

Actualmente, se administra siempre bajo anestesia y tiene unas indicaciones muy precisas:

- Depresión Mayor resistente
- Psicosis persistente
- Catatonia

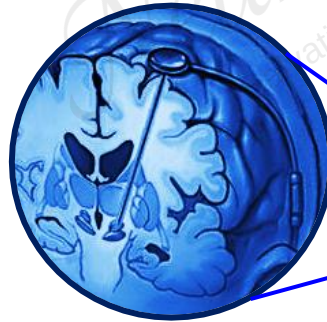
(70') provocó una disminución drástica de su utilización en centros públicos y un aumento en los centros privados.





*Estimulación cerebral profunda

Implantación de un micro-electrodo en un área muy específica del cerebro, en general Cíngulo Anterior.



El micro electrodo va **unido** a una pequeña **batería que provoca un estímulo eléctrico** en el área seleccionada. Este a periodicidad que requiera cada caso. Los datos de que disponemos son sobre una muestra muy limitada de pacientes.

Los pacientes son seleccionados por tener un cuadro Depresivo especialmente grave y resistente a tratamientos convencionales, así como en casos de Parkinson.

